

Burnout – Studien, Bücher & Quellen

Recherche-Dossier mit Schwerpunkt Christina Maslach

Stand: August 2026 · Arbeitsgrundlage für die Pottpsycho-Folge

Kurzfassung für die Redaktion

- Burnout wird in der ICD-11 als arbeitsbezogenes Phänomen, nicht als eigenständige Krankheit klassifiziert.
- Maslach beschreibt Burnout multidimensional: Erschöpfung, Zynismus/Distanz und reduzierte berufliche Wirksamkeit.
- Maslach & Leiter verschieben den Blick vom „defizitären Individuum“ auf die Passung zwischen Mensch und Arbeitsumfeld: Arbeitsbelastung, Kontrolle, Anerkennung, Gemeinschaft, Fairness und Werte.
- Für Deutschland gibt es keine aktuelle, einheitliche repräsentative Burnout-Prävalenz. Ältere DEGS1-Daten und BAuA-Daten sind als Referenz nutzbar; aktuelle Erschöpfungs-/Fatigue-Daten dürfen nicht als Burnout-Prävalenz ausgegeben werden.
- Gesundheitliche Folgen sind überwiegend als Zusammenhänge/Risiken zu formulieren, nicht als einfache Kausalbehauptungen.

1. Definition und diagnostische Einordnung

Für die Folge ist eine saubere Begriffsklärung zentral. Die WHO beschreibt Burnout in der ICD-11 als Folge chronischen, nicht erfolgreich bewältigten Arbeitsstressors. Die drei Dimensionen sind Energieverlust/Erschöpfung, mentale Distanz bzw. Zynismus gegenüber der Arbeit und reduzierte berufliche Wirksamkeit. Burnout bezieht sich ausdrücklich auf den beruflichen Kontext und ist in der ICD-11 nicht als eigenständige Krankheit klassifiziert.

World Health Organization (2019). Burn-out an “occupational phenomenon”: International Classification of Diseases. *[Primärquelle]*

Primärquelle für die ICD-11-Einordnung und die drei Kerndimensionen. Sehr gut geeignet, um in der Folge Burnout von allgemeiner Erschöpfung und von Diagnosen wie Depression abzugrenzen.

[Quelle / DOI öffnen](#)

2. Christina Maslach: die zentralen Arbeiten

Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). Job Burnout. Annual Review of Psychology, 52, 397–422. DOI: 10.1146/annurev.psych.52.1.397. *[Kernstudie]*

Grundlagenreview. Definiert Burnout als mehrdimensionales arbeitsbezogenes Syndrom und fasst die Forschung zu Erschöpfung, Zynismus und Ineffektivität zusammen. Für Meikes fachlichen Einstieg wahrscheinlich die wichtigste Einzelquelle.

[Quelle / DOI öffnen](#)

Leiter, M. P., & Maslach, C. (1999). Six areas of worklife: A model of the organizational context of burnout. Journal of Health and Human Services Administration, 21(4), 472–489. PMID: 10621016. [Kernstudie]

Die zentrale Quelle für die sechs Arbeitsbereiche: Workload, Control, Reward, Community, Fairness und Values. Das Modell eignet sich ideal als dramaturgisches Rückgrat der Podcastfolge.

[Quelle / DOI öffnen](#)

Maslach, C., & Leiter, M. P. (2016). Understanding the burnout experience: recent research and its implications for psychiatry. World Psychiatry, 15(2), 103–111. DOI: 10.1002/wps.20311. [Kernreview]

Sehr gut lesbarer, frei zugänglicher Überblick. Diskutiert Definition, Messung, Ursachen, Folgen, Burnout–Depressions-Abgrenzung und Interventionen. Besonders nützlich für die Frage, warum Burnout nicht auf Erschöpfung reduziert werden sollte.

[Quelle / DOI öffnen](#)

Maslach, C., Jackson, S. E., & Leiter, M. P. (1996). Maslach Burnout Inventory Manual (3rd ed.). Consulting Psychologists Press. [Messinstrument]

Standardwerk zum Maslach Burnout Inventory (MBI). Für den Podcast wichtig als Hintergrund zur Messung; nicht als frei verfügbarer Selbsttest behandeln. Das MBI ist ein geschütztes Instrument.

3. Maslach & Leiter – Bücher

Maslach, C., & Leiter, M. P. (1997). The Truth About Burnout: How Organizations Cause Personal Stress and What to Do About It. San Francisco: Jossey-Bass. [Buch]

Klassisches Buch, das den organisationalen Blick auf Burnout popularisiert. Sehr passend zur Leitfrage der Folge: „Muss sich der Mensch ändern – oder die Arbeit?“

[Quelle / DOI öffnen](#)

Leiter, M. P., & Maslach, C. (2005). Banishing Burnout: Six Strategies for Improving Your Relationship with Work. Jossey-Bass/Wiley. [Buch]

Praxisorientierte Weiterentwicklung der sechs Arbeitsbereiche. Hilfreich für den Lösungsblock der Folge, weil nicht nur individuelle Selbstfürsorge, sondern die Beziehung zwischen Person und Arbeitsplatz betrachtet wird.

[Quelle / DOI öffnen](#)

Maslach, C., & Leiter, M. P. (2022). The Burnout Challenge: Managing People's Relationships with Their Jobs. Harvard University Press. DOI: 10.4159/9780674287297. [Buch – besonders empfohlen]

Aktuelles Buch von Maslach und Leiter. Betont erneut, dass Burnout nicht allein als individuelles Resilienzproblem behandelt werden sollte, sondern dass Organisationen Arbeitsbedingungen verändern müssen.

[Quelle / DOI öffnen](#)

4. Gesundheitliche, psychische und berufliche Folgen

Salvagioni, D. A. J., Melanda, F. N., Mesas, A. E., González, A. D., Gabani, F. L., & Andrade, S. M. (2017). Physical, psychological and occupational consequences of job burnout: A systematic review of prospective studies. PLOS ONE, 12(10), e0185781. DOI: 10.1371/journal.pone.0185781. [Systematisches Review]

Systematisches Review prospektiver Studien. Berichtet Zusammenhänge von Burnout mit u. a. depressiven Symptomen, psychischer Beeinträchtigung, anhaltender Fatigue, muskuloskelettalen Beschwerden, kardiovaskulären Outcomes, Arbeitsunzufriedenheit und Fehlzeiten. Für die Folge unbedingt vorsichtig formulieren: „assoziiert mit“ bzw. „in prospektiven Studien prädiktiv“, nicht pauschal „Burnout verursacht“.

[Quelle / DOI öffnen](#)

Koutsimani, P. et al. / Frontiers in Psychiatry (2024). The influence of burnout on cardiovascular disease: a systematic review and meta-analysis. DOI: 10.3389/fpsyt.2024.1326745. [Meta-Analyse]

Neuere systematische Übersichtsarbeit und Meta-Analyse. In der gepoolten Analyse war Burnout mit einem erhöhten kardiovaskulären Risiko assoziiert (adjustierte Gesamtschätzung OR 1,21). Die Autoren weisen auf Limitationen der Evidenz hin.

[Quelle / DOI öffnen](#)

5. Burnout und Depression – wichtige Abgrenzung

Maslach, C., & Leiter, M. P. (2016). Understanding the burnout experience: recent research and its implications for psychiatry. World Psychiatry, 15(2), 103–111. [Review]

Maslach und Leiter diskutieren ausdrücklich die Überschneidung und Abgrenzung zwischen Burnout und psychischen Erkrankungen. Gute Grundlage für Meikes Satz: „Burnout und Depression können sich ähneln und gemeinsam auftreten – sie sind aber konzeptuell nicht identisch.“

[Quelle / DOI öffnen](#)

Bianchi, R., Schonfeld, I. S., & Laurent, E. (2015). Burnout–depression overlap: A review. Clinical Psychology Review, 36, 28–41. [Kontroverse/Abgrenzung]

Kritischer Review zur erheblichen Überlappung von Burnout und Depression. Nützlich als Gegenperspektive zu einer zu scharfen Trennung der Konstrukte. Für die Redaktion wichtig, weil die wissenschaftliche Debatte nicht vollständig abgeschlossen ist.

[Quelle / DOI öffnen](#)

6. Deutschland: Prävalenz und aktuelle Einordnung

Wichtig für die Sendung: Es gibt keine aktuelle, einheitliche Zahl, die seriös als „Burnout-Prävalenz Deutschlands 2026“ bezeichnet werden kann. Unterschiedliche Studien messen Diagnosen, Symptome, Erschöpfung oder Burnout mit unterschiedlichen Instrumenten. Diese Werte sind nicht austauschbar.

Maske, U. E., Riedel-Heller, S. G., Seiffert, I., Jacobi, F., & Hapke, U. (2016). Häufigkeit und psychiatrische Komorbiditäten von selbstberichtetem diagnostiziertem Burnout-Syndrom – Ergebnisse der bevölkerungsrepräsentativen DEGS1. Psychiatrische Praxis. DOI: 10.1055/s-0034-1387201. [Deutschland – Allgemeinbevölkerung]

Bundesweit repräsentative DEGS1-Daten (Erhebung 2008–2011; N=7.987). Selbstberichtete ärztliche/psychotherapeutische Burnout-Diagnose: Lebenszeitprävalenz 4,2 %, 12-Monats-Prävalenz 1,5

%). Unter den 12-Monats-Fällen bestand sehr häufig zusätzlich eine psychische Störung. Wegen des Alters der Daten nicht als aktuelle Prävalenz ausgeben.

[Quelle / DOI öffnen](#)

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA). Arbeit und Mentale Gesundheit (S-MGA, Welle 1).

[Deutschland – Beschäftigte]

Repräsentative Beschäftigtenstudie mit Erhebung 2011/2012. Berichtet Burnout-Symptomatik bei etwa 10 % der Männer und 11 % der Frauen. Zeigt außerdem Zusammenhänge mit hohen Arbeitsanforderungen sowie günstige Zusammenhänge von Handlungsspielraum, Kolleg*innen-Unterstützung und Führungsqualität.

[Quelle / DOI öffnen](#)

BAuA. Studie zur Mentalen Gesundheit bei der Arbeit (S-MGA), dritte Welle 2023/24. *[Aktuelle Forschung]*

Die dritte Erhebungswelle soll die deutsche Datenbasis aktualisieren. Das Projekt läuft; das geplante Projektende ist 2028. Daher derzeit nicht als abgeschlossene neue Burnout-Prävalenzquelle verwenden.

[Quelle / DOI öffnen](#)

Robert Koch-Institut: GEDA 2023 – Fatigue in der erwachsenen Bevölkerung Deutschlands. *[Deutschland – Fatigue, nicht Burnout]*

Aktuelle bevölkerungsbezogene Referenz für Erschöpfung/Fatigue: 29,7 % der Erwachsenen berichteten Fatigue; bei 18–29-Jährigen 39,6 %. Diese Zahlen sind ausdrücklich KEINE Burnout-Prävalenz. Sie eignen sich gerade deshalb gut für die Podcastfrage: „Erschöpft = Burnout?“

[Quelle / DOI öffnen](#)

BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2024. Die wichtigsten Fakten und Fragen. *[Deutschland – Arbeitswelt]*

Große aktuelle Erwerbstätigenbefragung mit 20.006 Befragten (Feldzeit Oktober 2023 bis April 2024). Nützlich für aktuelle Arbeitsbedingungen und Beschwerden, aber nicht automatisch als Burnout-Prävalenz zu interpretieren.

[Quelle / DOI öffnen](#)

7. Berufsgruppen und Arbeitsbedingungen

Burr, H., Buchallik, F., Ingenfeld, P., Moser, J., Rösler, U., & Zeibig, R. (2021). Psychische Belastung und mentale Gesundheit bei personenbezogenen Tätigkeiten. BAuA. DOI: 10.21934/baua:fakten20211210. *[Deutschland – Berufsgruppen]*

In Deutschland arbeiten gut 12 Millionen Menschen – etwa ein Drittel der Erwerbstätigen – in personenbezogenen Tätigkeiten wie Beraten, Pflegen, Retten, Schützen oder Unterrichten. Gute Quelle für den Berufsgruppen-Block, ohne daraus pauschal eine Burnout-Rangliste abzuleiten.

[Quelle / DOI öffnen](#)

Kersten, N., Formazin, M., & Müller, G. (2021). Burnout und psychosoziale Arbeitsbedingungen in Berufsgruppen mit hohen kognitiven Anforderungen. Zentralblatt für Arbeitsmedizin, 71, 8–18. DOI: 10.1007/s40664-020-00409-3.

[Deutschland – Berufsgruppen]

Vergleicht Softwareentwicklung, Werbung und Publizistik mit der Beschäftigtenpopulation. Wichtig für die Aussage: Nicht die Berufsbezeichnung allein entscheidet; psychosoziale Arbeitsbedingungen, insbesondere quantitative Anforderungen, sind zentral.

[Quelle / DOI öffnen](#)

BAuA (2021). Psychosoziale Arbeitsbedingungen und Burnout im Längsschnitt der Studie zur mentalen Gesundheit bei der Arbeit (S-MGA). *[Deutschland – Längsschnitt]*

Längsschnittanalyse mit N=2.005. Besonders wertvoll, weil Veränderungen psychosozialer Arbeitsbedingungen mit Veränderungen von Burnout untersucht werden. Passt direkt zum Maslach-Schwerpunkt auf Organisation und Person–Job-Passung.

[Quelle / DOI öffnen](#)

8. Messung von Burnout

Für die Folge sollte das Maslach Burnout Inventory (MBI) als historisch und wissenschaftlich einflussreiches Messinstrument erklärt werden, aber nicht als Diagnosetest für Hörer*innen. Burnout-Forschung verwendet zudem andere Instrumente, z. B. Oldenburg Burnout Inventory (OLBI), Copenhagen Burnout Inventory (CBI) oder neuere Burnout Assessment Tools. Unterschiedliche Instrumente und Cut-offs tragen dazu bei, dass Prävalenzzahlen stark variieren.

Maslach, C., Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. *Journal of Occupational Behaviour*, 2, 99–113. [Messung]

Frühe psychometrische Grundlage des MBI. Historisch wichtig für die Operationalisierung des mehrdimensionalen Burnout-Konzepts.

[Quelle / DOI öffnen](#)

Kristensen, T. S., Borritz, M., Villadsen, E., & Christensen, K. B. (2005). The Copenhagen Burnout Inventory: A new tool for the assessment of burnout. *Work & Stress*, 19, 192–207. [Messung]

Alternatives Burnout-Instrument. Hilfreich, um zu erklären, warum verschiedene Studien zu unterschiedlichen Prävalenzzahlen kommen können.

[Quelle / DOI öffnen](#)

9. Was hilft? Intervention und Prävention

Für die Schlussphase der Podcastfolge empfiehlt sich eine zweigleisige Darstellung: individuelle Unterstützung kann sinnvoll sein, aber bei arbeitsbedingten Ursachen sollten Arbeitsbedingungen und Organisation mitverändert werden. Genau dieser Punkt ist zentral in Maslachs und Leiters Arbeiten.

Maslach, C., & Leiter, M. P. (2022). *The Burnout Challenge*. Harvard University Press. [Praxis/Organisation]

Für organisationale Prävention und den Perspektivwechsel weg von rein individueller „Selfcare“. Gut für konkrete Beispiele zu den sechs Bereichen.

[Quelle / DOI öffnen](#)

Maslach, C., & Leiter, M. P. (2016). Understanding the burnout experience. *World Psychiatry*, 15(2), 103–111. [Intervention]

Betont die begrenzte Evidenzbasis für Interventionen und die Notwendigkeit, sowohl Person als auch Arbeitskontext zu berücksichtigen.

[Quelle / DOI öffnen](#)

10. Empfohlene Lesereihenfolge für die Vorbereitung

Priorität	Quelle	Wofür?
1	Maslach, Schaufeli & Leiter (2001) – Job Burnout	Grundmodell und drei Dimensionen.

2	Leiter & Maslach (1999) – Six Areas of Worklife	Die sechs Bereiche für den Hauptteil der Folge.
3	Maslach & Leiter (2016) – Understanding the burnout experience	Aktualisierte Einordnung, Depression, Messung und Intervention.
4	Maslach & Leiter (2022) – The Burnout Challenge	Praxisnaher organisationaler Blick.
5	Salvagioni et al. (2017)	Gesundheitliche und berufliche Folgen.
6	BAuA S-MGA + BIBB/BAuA 2024 + RKI GEDA 2023	Deutschlandblock: Arbeitswelt, Burnout-Symptome und aktuelle Erschöpfungsdaten.

11. Formulierungen für die Podcastfolge – wissenschaftlich sauber

Nicht: „Burnout ist eine Krankheit.“

Besser: „Die WHO klassifiziert Burnout als arbeitsbezogenes Phänomen, nicht als eigenständige Krankheit.“

Nicht: „Ein Drittel der Deutschen hat Burnout.“

Besser: „Aktuelle Studien zeigen viel Erschöpfung/Fatigue; das ist nicht gleichbedeutend mit Burnout.“

Nicht: „Burnout verursacht Herzkrankheiten.“

Besser: „Burnout ist in Studien mit einem erhöhten Risiko für bestimmte körperliche Erkrankungen assoziiert; die Kausalität ist nicht für alle Outcomes geklärt.“

Nicht: „Pflegekräfte haben am häufigsten Burnout.“

Besser: „Personenbezogene Berufe sind häufig hohen psychosozialen Anforderungen ausgesetzt; das Risiko hängt stark von konkreten Arbeitsbedingungen ab.“

Nicht: „Yoga hilft bei Burnout nicht.“

Besser: „Individuelle Strategien können helfen, reichen aber möglicherweise nicht aus, wenn chronische Fehlpassungen im Arbeitsumfeld bestehen.“

Nicht: „Burnout wird zur Depression.“

Besser: „Burnout und Depression überschneiden sich deutlich und können gemeinsam auftreten; anhaltende oder schwere Beschwerden sollten diagnostisch abgeklärt werden.“

12. Kompakte Quellenliste

- Leiter, M. P., & Maslach, C. (1999). Six areas of worklife: a model of the organizational context of burnout. *Journal of Health and Human Services Administration*, 21(4), 472–489.
- Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). Job Burnout. *Annual Review of Psychology*, 52, 397–422. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.397>

- Maslach, C., & Leiter, M. P. (2016). Understanding the burnout experience: recent research and its implications for psychiatry. *World Psychiatry*, 15(2), 103–111. <https://doi.org/10.1002/wps.20311>
- Maslach, C., & Leiter, M. P. (1997). *The Truth About Burnout*. Jossey-Bass.
- Leiter, M. P., & Maslach, C. (2005). *Banishing Burnout*. Jossey-Bass.
- Maslach, C., & Leiter, M. P. (2022). *The Burnout Challenge*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.4159/9780674287297>
- Salvagioni, D. A. J., et al. (2017). Physical, psychological and occupational consequences of job burnout. *PLOS ONE*, 12(10), e0185781. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185781>
- The influence of burnout on cardiovascular disease: a systematic review and meta-analysis (2024). *Frontiers in Psychiatry*. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2024.1326745>
- Maske, U. E., et al. (2016). Häufigkeit und psychiatrische Komorbiditäten von selbstberichteten diagnostiziertem Burnout-Syndrom. *Psychiatrische Praxis*. <https://doi.org/10.1055/s-0034-1387201>
- BAuA. Arbeit und Mentale Gesundheit (S-MGA). <https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Berichte/F2250-2>
- BAuA. Psychische Belastung und mentale Gesundheit bei personenbezogenen Tätigkeiten (2021). DOI: 10.21934/baua:fakten20211210
- Kersten, N., Formazin, M., & Müller, G. (2021). Burnout und psychosoziale Arbeitsbedingungen in Berufsgruppen mit hohen kognitiven Anforderungen. <https://doi.org/10.1007/s40664-020-00409-3>
- RKI. GEDA 2023 – Fatigue in der erwachsenen Bevölkerung Deutschlands.
- BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2024 – Die wichtigsten Fakten und Fragen.
- World Health Organization (2019). Burn-out an occupational phenomenon: ICD-11.

Hinweis zur Verwendung

Dieses Dossier ist als redaktionelle und wissenschaftliche Arbeitsgrundlage für Pottpsycho gedacht, nicht als medizinische Leitlinie. Bei Zahlen im Podcast sollte jeweils genannt werden, was genau gemessen wurde (Diagnose, Burnout-Symptomatik, Erschöpfung/Fatigue, Arbeitsunfähigkeit) und aus welchem Erhebungsjahr die Daten stammen. Gerade bei Burnout sind unterschiedliche Messinstrumente und Definitionen ein wesentlicher Grund für stark abweichende Prävalenzangaben.